

Mentalizacja w NPD

Zdolność rozumienia cudzych stanów umysłu — w NPD **asymetryczna**. Praca: postawa nie-wiedzącego, rekonstrukcja sytuacji z trzech perspektyw.

CZAS: 15 min **Wersja edukacyjna** **ŹRÓDŁO:** Bateman & Fonagy (2016); Diamond i wsp. (2014, 2022)

JAK UŻYWAĆ

1 · Zrozumiesz, czym jest *mentalizacja* (sekcja 01) i dlaczego w NPD jest **asymetryczna**. **2** · Poznasz trzy *tryby przed-mentalistyczne*, w które wpada pacjent w stresie (sekcja 02). **3** · Nauczysz się postawy *not-knowing* i rekonstrukcji **z trzech perspektyw** (sekcja 03). **4** · Zobaczysz, dlaczego MBT wymaga *dwóch terapeutów* i 18 miesięcy (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Mentalizacja to **zdolność rozumienia własnych i cudzych zachowań przez stany umysłu** — uczucia, pragnienia, przekonania, intencje. W NPD jest **asymetryczna**: dobrze rozwinięta wobec siebie (samoanaliza), **upośledzona wobec innych**. *Mentalization-Based Treatment* (MBT, Bateman & Fonagy 2004) — pierwotnie opracowany dla zaburzenia osobowości borderline (BPD), w randomizowanym badaniu kontrolowanym istotnie zredukował samouszkodzenia i hospitalizacje. Diamond i wsp. (2014, 2022) zaadaptowali MBT dla NPD. Mechanizm w NPD: pacjent operuje w trybie *przed-mentalistycznym* wobec partnera — „on/ona ma intencje wrogie” albo „jest narzędziem do moich celów”. Brak uznania *osobnego umysłu* drugiej osoby prowadzi do dehumanizacji i *acting-out*: krzyku, manipulacji, zerwania kontaktu (ang. *ghosting*). Trzy tryby przed-mentalistyczne (Fonagy): (1) *teleologiczny* — „liczy się tylko to, co widać”; (2) *równoważności psychicznej* — „moja interpretacja = rzeczywistość”; (3) *pretensjonalny* — oderwane fantazje o intencjach drugiej osoby. Cel: integracja w **refleksyjną mentalizację**. Kluczowa technika: postawa **nie-wiedzącego** (ang. *not-knowing stance*) — terapeuta nie wie „lepiej”, tylko *współbada* z pacjentem. Pytanie: „co by mogło być w jego/jej głowie?” zamiast oskarżeń lub interpretacji. W sesji: rekonstrukcja sytuacji konfliktowej **z trzech perspektyw** — moja, partnera, neutralnego obserwatora. **Protokół**: MBT w klasycznej wersji wymaga 2 terapeutów (indywidualny + grupowy), 18 miesięcy. Po roku istotny spadek wskaźników impulsywności. W NPD szczególnie istotna **powolność** — nie wymuszać refleksji w trybie obronnym.

01

Asymetryczna mentalizacja w NPD

MENTALIZACJA WOBEC SIEBIE

Dobra, czasem nadrozwinięta. Wnikliwa samoanaliza, „rozumiem, dlaczego tak czuję”, „wiem, jakie mam motyw”. Pacjent *opowiada o sobie* godzinami.

MENTALIZACJA WOBEC INNYCH

Upośledzona. „On/ona ma wrogie intencje”, „chcę mnie wykorzystać”, „jest narzędziem”. Brak uznania *osobnego umysłu* drugiej osoby z własnymi potrzebami.

Paradoksalnie: empatia *poznawcza* może być wysoka (rozumiem, co czuje), ale *nie* przekłada się na uznanie autonomii drugiej osoby. „Wiem, że jesteś smutna — i co z tego? Mnie też smutek dotknął.”
KOMPENDIUM NARZĘDZI TERAPEUTYCZNYCH: OSOBOWOŚĆ NARCYSTYCZNA · LINEART V2
 Brak **integracji**: emocje innych są zauważane, ale nie biorą się pod uwagę w decyzjach.

02 ☉ Trzy tryby przed-mentalistyczne

1 · TELEOLOGICZNY

tylko działania mówią prawdę

„Jeśli mnie kochasz, **udowodnij** kwiatami.” Słowa, zapewnienia, wewnętrzne stany — nieważne. Liczą się tylko *obserwowalne czyny*.

2 · RÓWNOWAŻNOŚĆ PSYCHICZNA

moje myśli = rzeczywistość

„Czuję, że **na pewno** kłamię.” Subiektywne przekonanie traktowane jako fakt obiektywny. Brak miejsca na alternatywne interpretacje.

3 · PRETENSJONALNY

oderwane fantazje

Rozbudowane teorie o czyichś motywach, niezakorzenione w rzeczywistych sygnałach. Często paranoidalne („chce mnie zniszczyć”), bez podstaw.

Wszystkie trzy tryby *wzmacniają* się w **stresie** i przy *narcissistic injury*. W spokojnym stanie pacjent może być refleksyjny — w gniewie wraca do przed-mentalizacji. Cel terapii: *poszerzyć okno refleksyjności*.

03 ✎ Trzy perspektywy — rekonstrukcja sytuacji

Wybierz **ostatnią sytuację konfliktową** i opisz ją *trzy razy*: z perspektywy własnej, drugiej osoby, neutralnego obserwatora. Cel: zauważyć, że **nie ma jednej prawdy**.

1 · MOJA PERSPEKTYWA

— co czułem/-am, myślałem, robiłem

2 · JEJ/JEGO PERSPEKTYWA

— co mogła czuć i myśleć

3 · OBSERWATOR

— co zobaczyłaby kamera

04 💡 Protokół MBT — czego wymaga

STRUKTURA

2 terapeutów (indywidualny + grupowy). 18 miesięcy. Postawa *not-knowing* — terapeuta modeluje mentalizację: „*nie wiem, ale zastanówmy się...*”

CZEGO UNIKAĆ

Nie pouczać („pomyśl wreszcie o niej”). Nie interpretować autorytatywnie. Nie wymuszać refleksji w trybie obronnym. *Pytaj, nie oskarżaj*.

Klucz: mentalizacja to *umiejętność*, nie cecha — można ją trenować. MBT (Bateman & Fonagy 2004) ma silne dowody RCT dla BPD; adaptacja Diamond i wsp. (2014, 2022) obiecuje podobne efekty dla NPD. **Postawa nie-wiedzącego** jest podstawową techniką — terapeuta *modeluje* mentalizację, zamiast jej pouczać. Pytanie „*co by mogło być w jego/jej głowie?*” otwiera przestrzeń, której pacjent nie ma w trybie obronnym. Po 1 roku regularnego treningu — istotny spadek impulsywności i poprawa jakości relacji.